（四）胸腔穿刺抽液治疗

1.大量胸水者每周抽液 2-3 次，首次抽液＜800ml，以后每次＜1000ml　2+8=10

2.抽胸水时若速度过**快**、抽液过**多**→复张后**肺水肿**　肺复张→肺里的血管也在复张→肺里的血液↑→压力↑→肺水肿
①患者剧烈咳嗽、**咳大量泡沫痰**、双肺满布湿啰音　肺泡里面有很多水
②停止抽液，立即吸氧，控制液体入量（必要时使用利尿剂和糖皮质激素）
增加肾小球滤过;减少ADH分泌

3.抽胸水时因刺激迷走神经可致**胸膜反应**（看到一个大针管害怕的样子）
①患者**血压↓**、头晕、面色苍白、心悸、**出汗**（血压低后通过压力感受性反射兴奋交感神经）
②停止抽液，平卧休息，监测血压防止休克，必要时给予**肾上腺素**
迷走神经→血压↓、头晕、面色苍白→窦弓反射→交感神经→心悸、出汗

瓦伯格效应原因
①无氧氧化步骤少,快
②G变乳酸后可再经糖异生
变G节省原料,利于持续生长

（五）胸腔积液的鉴别诊断

1.结核性胸水 VS 恶性胸水

	结核性胸水	恶性胸水（如**肺癌**）
表现	起病较慢、多为低热	起病较慢、多不发热或低热，多见于中老年
⭐**ADA**　腺苷脱氨酶	**＞45**（ADA 在淋巴细胞活性最高）	**＜45**（分化差）
CEA	＜10μg/L	＞10μg/L（或胸水/血清 CEA＞1）
LDH	＞200U/L　多个核细胞;中性粒细胞	＞500U/L　瓦伯格效应:即使氧气充足,也愿意无氧氧化
细胞	**＞500×10⁶**/L，以**单个核细胞（淋巴细胞）**为主　林妹妹	
	胸膜腔内渗出很多纤维素(易粘连)　可有**血性胸水**　常有血性胸水:肿瘤、结核、肺栓塞	
治疗	**尽快抽净胸水**　纤溶酶原激活剂 不向胸膜腔内注射抗结核药，可注入链激酶	化学性胸膜固定术 （胸膜腔给抗肿瘤药、滑石粉）无菌性炎症

效果不好+容易耐药,且异烟肼穿透性强可以进入胸水　溶解纤维蛋白降低粘连概率

肺是否能复张
- X:胸腔置管引流,后期切肺
- √:胸腔置管引流或胸膜固定术

2.脓胸（最常继发于肺部感染）

（1）**急性脓胸**　VS 结核:慢性起病,长期低热,单个核细胞为主　VS 肿瘤:慢性起病,不发热或低中热,单个核细胞为主

①急性起病，**寒战高热为主**，纵隔可向健侧移位　PH<7仅见于急性脓胸、食管破裂

②**ADA＞45**，**多个核细胞（中性粒细胞）**为主，**胸水细胞可＞10×10⁹**、**pH 可＜7**、LDH＞500

③治疗：控制感染（全身及胸膜腔内给予足量抗生素），**引流（最基本治疗）**，用生理盐水或 2%$NaHCO_3$ 冲洗胸膜腔稀释脓液以利于引流，可注入链激酶以防止胸膜粘连

若胸水细胞没有＞10×10⁹、PH没有＜7,不可以排除急性脓胸

抗感染时淋巴细胞↑→ADA↑　VS 结核:全身用抗结核药,不向胸膜腔注射抗结核药

（2）慢性脓胸　胶原纤维收缩

①多长期低热，急性发作时寒战高热。可有胸廓塌陷、纵隔向患侧移位、杵状指　硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎

②治疗：
病程短、纤维化不严重的慢性脓胸：胸膜纤维板剥脱术
病程长、纤维化严重、肺部并发症较多者：胸膜纤维板剥脱术+病肺切除术

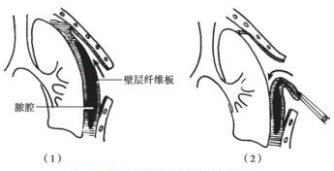


图 28-2　胸膜纤维板剥脱术(示意图)
(1)剥除壁层纤维板　(2)剥除脏层纤维板